



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
**Pelayanan Geriatri Terpadu bagi Tenaga
Kesehatan**

TAHUN 2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



TOR (TERM OF REFERENCE)
Pelayanan Geriatri Terpadu bagi Tenaga Kesehatan
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Definisi pasien geriatri berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no 79 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Sedangkan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lansia cenderung mengalami peningkatan, ditahun 2000 sebanyak 14.439.967 jiwa (7,18%) dan tahun 2010 sebanyak 23.992.553 jiwa (11,34%). Indonesia menempati peringkat ke-10 dunia untuk populasi manusia lansia. Pada 2020 diperkirakan jumlah lansia mencapai 28,8 juta atau 11% dari total populasi penduduk.

Pelayanan Geriatri adalah pelayanan kesehatan usia lanjut dengan pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek medik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta aspek sosial dan psikologik pada pasien usia lanjut. Definisi pasien geriatri berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no 79 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin.

Pasien geriatri memiliki karakteristik khusus yaitu multipatologi (pada satu pasien terdapat lebih dari satu penyakit yang umumnya bersifat kronik degeneratif), menurunnya daya cadangan faali, berubahnya gejala dan tanda penyakit dari yang klasik, terganggunya status fungsional (kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari), sering terdapat gangguan nutrisi, berupa gizi kurang atau gizi buruk. Masalah utama yang dihadapi lansia adalah masalah biologi (rambut, gigi, penglihatan, dll), Kesehatan (rentan terhadap penyakit seperti DM, HT dan Psikis), dan masalah sosial (kesepian, merasa tidak berguna dan kurang percaya diri). Sindrom geriatri adalah serangkaian kondisi klinis pada orang berusia lanjut (lansia) yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup, kecacatan, bahkan risiko kematian. Sindrom geriatri adalah kondisi yang disebabkan oleh berbagai faktor serta melibatkan banyak bagian tubuh. Empat faktor risiko yang umum terdapat pada sindrom geriatri antara lain usia lanjut, gangguan fungsi kognitif, gangguan menjalani aktivitas sehari-hari dan gangguan mobilitas. Hal ini mendasari gagasan mendirikan klinik Lansia yang memiliki prinsip melayani masalah pada lansia secara holistik dan harus menjadi prioritas utama.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 3.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sesuai PMK No. 79/2024 Tentang Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pelatihan pelayanan geriatrik terpadu di RS diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pelayanan geriatri yang berkualitas, terpadu dan aman.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengaplikasikan apa yang didapat dari pelatihan pelayanan geritari ini di RS Prima Husada Sukorejo.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menurunkan morbiditas dan mortalitas pada pasien lanjut usia.
- 2) Memberikan pelayanan diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif yang komprehensif.
- 3) Meningkatkan kemampuan fungsional dan kemandirian lansia.
- 4) Memberikan edukasi kepada keluarga dan pendamping (caregiver) dalam merawat lansia

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 SUSUNAN PANITIA

NO	SUSUNAN PANITIA	NAMA	TUGAS
1	Ketua Panitia	dr. Dimas Aryo Pamungkas,Sp.PD	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara. Hasil akhir : LPJ
2	Sekretaris	Erlangga Shadyakara,S.Kep.,Ns	bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen. Hasil akhir : 1) notulen 2) LPJ
3	Moderator	Riska Amalia Putri,S.Tr.Gz	bertanggung jawab sebagai moderator dan mengaktifkan tanya jawab peserta. Hasil akhir: ringkasan persesi dan tanya jawab
4	Absensi	Shokhibatul Khilmin.N., AMd.,Kep	bertanggung jawab terhadap kelengkapan absensi dan menyiapkan serta membagikan kuesioner pelathan. Hasil akhir: rekap absensi dan kuesioner pelatihan
5	Sie Dokumentasi	Apt. Miftakhul Rohman.P.,S.Farm	bertanggung jawab sebagai fotografer. Hasil akhir: foto di LPJ
6	Sie Perlengkapan	Dimas Ragil AMd.Kep	bertanggung jawab terhadap kelengkapan peralatan, peminjaman, dan pengembalian alat. Mengambilkan alat-alat yang belum tersedia saat acara
7	Sie Penunjang	Sekretaris RSPHS (MONEV : SDM, PKRSRM)	bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan
8	Sie Pretest dan Posttest	Yuris Tiaravani, AMd	bertanggung jawab terhadap pembagian, pelaksanaan,



			penilaian pre-post test. Hasil akhir : rekap pre-post test
--	--	--	--

2.2 RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pelatihan pelayanan geriatrik terpadu RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2026 Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tanggal : 20 Mei 2026

Waktu : 10.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Ruang Meeting Sekretaris Lantai 3 RS Prima Husada Sukorejo

2.3 RENCANA RAPAT PANITIA PENYELENGGARAAN

JUDUL MATERI	SASARAN	NARASUMBER	METODE	PERLENGKAPAN	FREKUENSI PELAKSANAAN	DASAR MATERI	OUTPUT TRAINING	TARGET TRAINING JANGKA PANJANG
Pelatihan pelayanan 5eriatric terpadu	1. Dokter 2. Perawat 3. Gizi 4. Farmasi	Erlangga Shadyakara, S.Ke p.,Ns	1. Pre-Post Test 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanya Jawab	a. LCD b. Laptop c. Sound system d. Alat Tulis	1x / tahun	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 3. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/V III/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sesuai PMK No. 79/2024 Tentang Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit.	1. Tenaga kesehatan mampu mengenali prinsip-prinsip pelayanan geritri. 2. Peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kompeten dalam menangani lansia, termasuk melakukan pengkajian fisik dan fungsional. 3. Penggunaan checklist geritri sebelum, selama, dan setelah tindakan 4. Pencatatan evaluasi pelayanan geriatric dan monitoring, serta evaluasi pasca-pelayanan menjadi lebih lengkap dan akurat.	1. Seluruh unit yang melakukan pengkajian 5eriatric mengikuti standar yang sama (SOP, 5eriatric, checklist) 2. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengaplikasikan apa yang didapat dari pelatihan pelayanan 5eriatric ini dalam kegiatan pelayanan 3. Seluruh tenaga yang terlibat memiliki kompetensi tersertifikasi (mis. Melakukan pengkajian pelayanan 5eriatric.

Outline Training

NO	OUTLINE	ISI PPT	PJ
1	Barcode absensi	QR code absensi	MC
2	Susunan acara	Tabel rundown acara	MC
4	Judul	Pelatihan pelayanan geriatic terpadu.	Narsum
5	Latar Belakang	Pelaksanaan pelayanan geriatic terpadu di RS merupakan prosedur pemberian pelayanan geriatic terhadap pasien. Oleh karena itu diperlukan tenaga kesehatan yang kompeten, ruangan dan alat yang memenuhi standar. Namun masih ditemukan fasilitas ruangan ,alat yang belum memenuhi geriatic6n belum adanya SOP pelaksanaan pelayanan geriatri	Narsum
6	Target	1. Dokter, Perawat, Apoteker dan farmasi bisa melakukan pengkajian geritri sesuai standart 2. Dokter, Perawat, Apoteker dan farmasi memahami dan mengidentifikasi alur prosedur 3. Dokter, Perawat, Apoteker dan farmasi memahami komplikasi terhadap penyakit kronis pada lansia 4. Dokter, Perawat, Apoteker dan farmasi memahami peningkatan efesiensi pelayanan geritari di RS	Narsum
7	Konsep dasar geriatic	1. Definisi geriatic 2. Konsep dasar geriatic metode CGA 3. Pendekatan nutrisi pada lansia 4. Implikasi klinis proses menua	Narsum
9	Penilaian pra-pelayanan geriatic	1. Penilaian metode CGA 2. Penilain gizi lansia 3. imformed	Narsum
10	Persiapan pelayanan geriatri	1. persiapan ruangan 2. persiapan alat penilaian metode CGA 3. persiapan pengkajian 4. peran tim geriatri	Narsum
11	Tehnik dan prosedus pelayanan geriatic	1. Alur pelaksanaan pelayanan geriatic 2. Pengkajian geriatic metode CGA 3. Monitoring pasien selama tindakan metode CGA 4. Dokumentasi selama pelayanan	Narsum
12	Kesimpulan	Penekanan pada hal-hal yang harus dilakukan setelah ini	MC

13	Post Test	QR code post test dengan waktu (estimasi 30 detik / pertanyaan)	MC
----	-----------	---	----

Rapat : Pre Training : Materi/ Bahasan Alur Persiapan dan Pelaksanaan Training

NO	LANGKAH	PJ	YANG TERLIBAT
Pre Training			
1	Mendiskusikan materi yang akan diberikan untuk training (materi berdasarkan outline training)	Erlangga Shadyakara, S. Kep Ns	Dokter, perawat, gizi dan farmasi
2	Pembuatan soal pre/post test & kunci jawaban	Erlangga Shadyakara, S. Kep Ns	Hasil materi di CC ke SDM
3	Pembuatan PPT berdasarkan materi yang sudah didiskusikan	Shokhibatul Khilmin.N., Amd.,Kep	Narasumber
4	Pengumpulan PPT materi maksimal H-7 acara	Shokhibatul Khilmin.N., Amd.,Kep	Narasumber
5	Menentukan moderator training	Shokhibatul Khilmin.N., Amd.,Kep	Panitia
6	Menyusun panitia (MC merangkap dokumentasi, IT sebagai operator)	Dimas Ragil Amd.Kep	Panitia
7	Membuat / membahas Form Evaluasi penyelenggara untuk narasumber	Dimas Ragil Amd.Kep	Dokter, perawat, gizi dan farmasi
8	Media apa saja yang perlu disiapkan agar diklat berjalan sesuai tujuan dan harapan	Dimas Ragil Amd.Kep	Panitia
9	Penyusunan slide host (PPT yang ditampilkan sejak awal mulai dari absensi, pre test, rundown, ppt materi, post test dijadikan 1 kesatuan)	Erlangga Shadyakara, S. Kep Ns	Panitia



2.4 SASARAN ATAU PESERTA

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Perawat	143
2	Apoteker	31
3	Dokter	1
4	Gizi	4
TOTAL		179

2.5 SUSUNAN ACARA LENGKAP

Rundown kegiatan

JAM	DURASI	MATERI	PEMATERI
Gelombang I			
08.00-08.15 WIB	15 menit	Pretest	Tim
08.15-09.45 WIB	60 menit	1. Definisi dan tujuan pelayanan geriatri 2. Memahami konsep dasar pengkajian CGA 3. Pendekatan gizi pada lansia	Erlangga Shadyakara,S.Kep.,Ns
		4. Penialain metode CGA 5. Kesimpulan	
	30 menit	Tanya Jawab	Tim
09.45-10.00 WIB	15 menit	Post test	Tim

2.6 NARASUMBER

1. Erlangga Shadyakara,S.Kep.,Ns

2.7 MEDIA

1. LCD
2. Laptop
3. Sound system

2.8 METODE

1. Pre-Post Test
2. Presentasi
3. Diskusi
4. Tanya Jawab

2.9 KEBUTUHAN ANGGARAN

NO.	RINCIAN KEBUTUHAN	JUMLAH	SATUAN (RP)	HARGA (RP)	SUMBER DANA
1	Snack pemateri	2 kardus	Rp 20.000	Rp 40.000	Dapur RSPHM
2	Aqua botol	2 botol	Rp 5.000	Rp 10.000	Dapur RSPHM
3	Aqua gelas	4 dus	Rp 25.000	Rp 100.000	Dapur RSPHM
4	Sertifikat	174	Rp 0	Rp 0	Internal Cetak Soft copy oleh SDM
Total				Rp 150.000	
Yang diajukan kepada PT Disa Prima Medika				Rp 150.000	



III. MONITORING – EVALUASI

3.1 MONITORING

NO	BAHASAN DAN KEGIATAN	PJ	YANG TERLIBAT/ YANG MASUK PANITIA
1	Memastikan training berjalan sesuai TOR dan rundown	SDM	PJ Training
2	Mencatat evaluasi yang ditemukan selama training berjalan	SDM	PJ Training
3	Memimpin evaluasi setelah training selesai	SDM	PJ Training
4	Mengirimkan link g-form evaluasi yang diisi oleh narasumber	SDM	Narasumber
5	Menyiapkan kredensial apabila materi training ada sesi praktek / role play	SDM	Ketua Komite terkait

3.2 EVALUASI

EVALUASI (POST TRAINING) JANGKA PENDEK

1	Merekapitulasi hasil nilai pre test dan post test	Erlangga Shadyakara,S.Kep.,Ns	Panitia
2	Melakukan evaluasi hasil penilaian baik untuk penyelenggara maupun untuk narasumber dan pengamatan perilaku peserta saat diklat (serius, mengantuk, antusias)	Erlangga Shadyakara,S.Kep.,Ns	Panitia
3	Menerbitkan sertifikat	SDM	SDM
4	Evaluasi kinerja panitia	SDM	SDM

EVALUASI (POST TRAINING) JANGKA PANJANG

1	Melakukan supervisi atau observasi kepatuhan peserta diklat terhadap regulasi dan materi-materi dalam diklat yang sudah diikuti	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	SDM dan PJ Bab PAB
2	Hasil supervisi dibahas di rapat koordinasi	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	PJ Bab PAB
3	Membuat RTL-TL-Evaluasi secara berkala	Siti Durotul Ibadiyah S. Kep Ns	PJ Bab PAB



IV. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Untuk mempertahankan nilai Akreditasi Rumah Sakit yang Paripurna. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan acara ini.

Mengetahui,
SDM RS Prima Husada

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Pasuruan, 19 Mei 2026
Ketua Panitia,

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Novia Ainur P, S.KM

dr. Dimas Aryo Pamungkas,Sp.PD

Disetujui oleh,
Direktur RS Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep